역류성 식도염 생활관리 안내

증상부터 식이·생활습관까지, 한눈에 이해하는 역류성 식도염

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한국인 10명 중 1명이 겪는 흔한 병입니다

서구화된 식습관과 비만이 늘며 해마다 늘고 있습니다

7~13%

한국 성인 유병률

성인 약 10명 중 1명꼴입니다

2회+

일주일에 2번 이상

대표 증상이 이만큼 잦으면 진단을 생각합니다

왜 관리해야 하나요

그대로 두면 식도가 좁아지거나(협착) 식도 점막이 위 점막처럼 바뀌는 바렛식도로 진행할 수 있고, 드물게 식도암 위험을 높입니다.

대부분 잘 조절됩니다

알맞은 약물치료와 생활관리로 대부분의 환자는 증상을 잘 조절할 수 있습니다.

Tip · 흔한 병이지만, 오래가면 식도에 변화가 쌓이므로 꾸준히 관리합니다.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

위 내용물이 식도로 거꾸로 올라오는 병입니다

위산이 식도 점막을 자극해 상처를 내는 만성 질환입니다

식도와 위 사이의 조임근이 약해짐

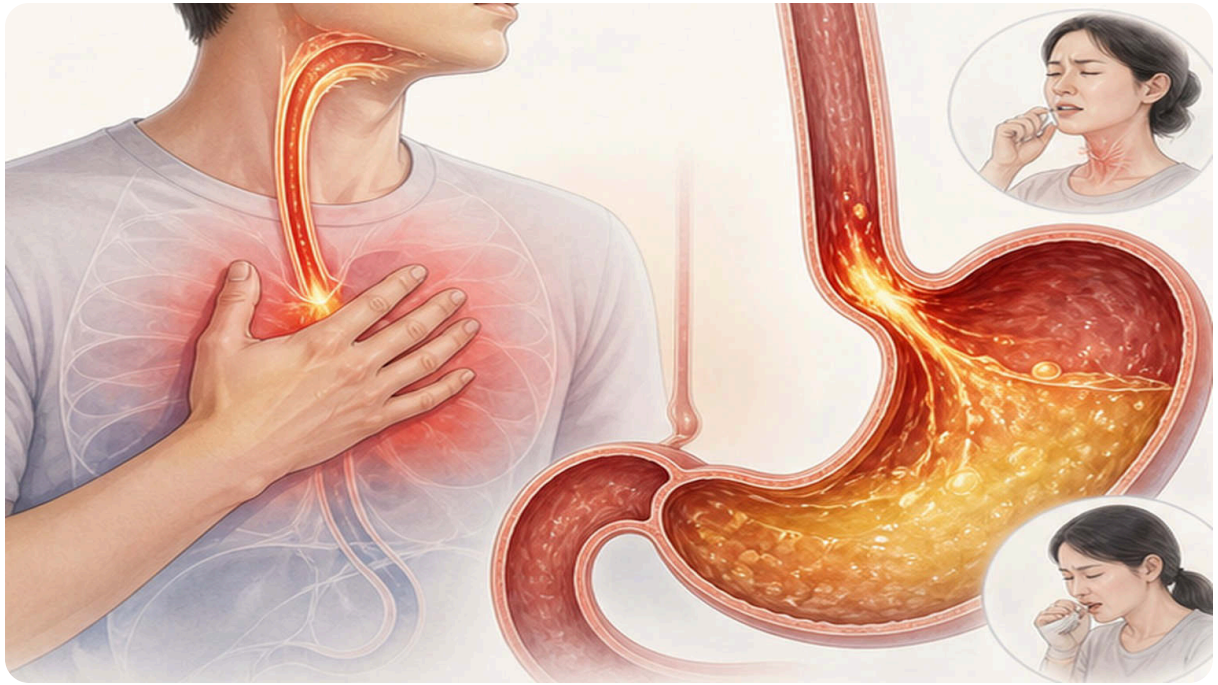
평소 닫혀 있어야 할 식도-위 경계(**하부식도괄약근**)가 약해지면 산성 위 내용물이 식도로 올라옵니다.

배 속 압력이 올라감

뱃살·과식·꽉 끼는 옷처럼 배 속 압력을 높이는 요인이 겹치면 역류가 더 쉬워집니다.

반복되면 합병증

역류가 되풀이되면 식도염, 식도가 좁아지는 협착, 바렛식도로 이어질 수 있습니다.



설명용 그림 · 위산(주황색)이 식도로 올라와 가슴쓰림·기침·신물을 일으킵니다.

Tip · 조임근 기능 저하와 배 속 압력 증가 — 이 두 가지가 만나는 곳에서 역류가 시작됩니다.

근거 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022

위 내용물이 올라오면 가슴이 쓰릴 수 있어요

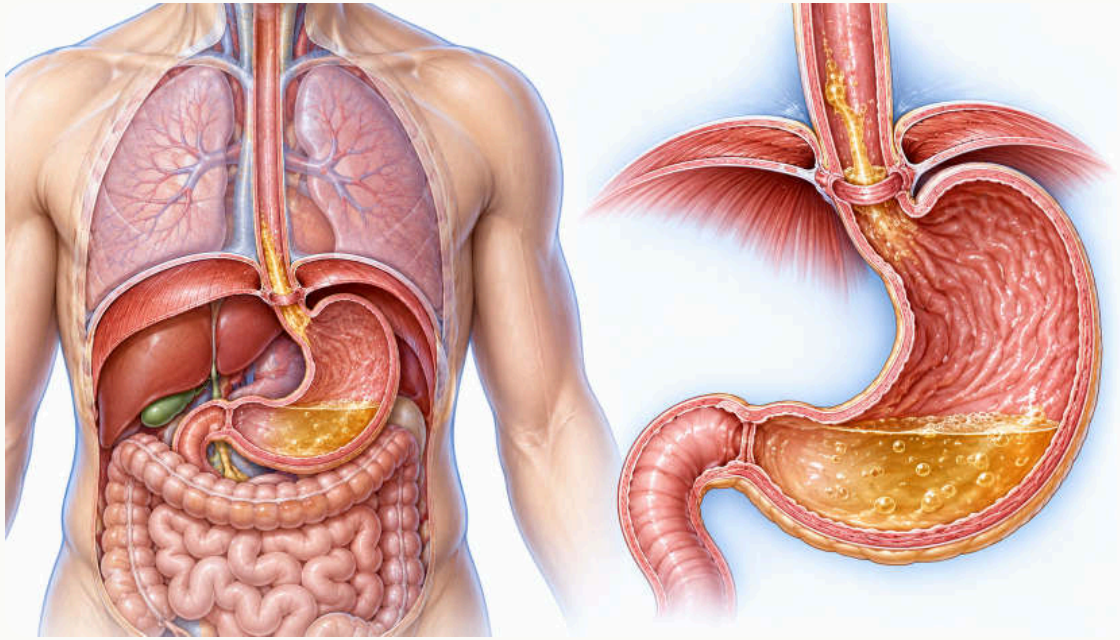
불편한 증상이나 합병증을 만드는 위식도 역류질환을 살펴봅니다.

위에서 식도로

위 내용물이 식도 쪽으로 역류하며 가슴쓰림·
신물역류가 나타날 수 있습니다. 불편한 증상이나
합병증을 일으키면 역류질환으로 설명합니다.

증상이 같아도 원인은 달라요

가슴쓰림을 느끼는 모든 사람에게 비정상적인 **위산 노출**이
있는 것은 아닙니다. 검사 결과와 증상 양상을 함께 봅니다.



위 내용물의 역류와 가슴·목 주변의 불편함을 설명한 그림입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

이런 증상이 있나요

대표 증상과 함께, 역류가 원인인 줄 모르기 쉬운 증상도 살펴봅니다

대표 증상

역류성 식도염에서 흔히 겪습니다

- 가슴쓰림 — 가슴 한가운데가 타는 듯함, 식후·누우면 심해짐
- 신물·쓴물 — 위 내용물이 입까지 올라옴
- 잦은 트림·소화불량 — 식후 부글거림·더부룩함

놓치기 쉬운 증상

역류가 원인일 수 있습니다

- 3주 넘는 기침·쉰 목소리
- 목에 무엇이 걸린 듯한 이물감이 반복됨
- 밤에 가슴 통증 — 심장 원인을 먼저 확인한 뒤 역류를 생각합니다

Tip · 3주 넘게 기침이 계속되면 역류도 한 번쯤 의심해 봅니다.

근거 · 몬트리올 정의 2006 · 리옹 합의 2.0 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

목 이물감·기침도 모두 역류 때문일까요?

가슴쓰림이 동반되는지와 객관적인 역류 근거가 중요합니다.

01

전형적인 증상

가슴쓰림·신물역류는 **산분비억제제 시험치료**를 고려할 수 있는 전형적인 증상입니다.

02

흉통·만성기침

객관적인 **GERD**가 있는 환자에서 PPI 치료 반응이 더 좋았습니다.

03

목 증상·천식

전형적인 **GERD** 증상 없이 식도 밖 증상만 있을 때는 PPI의 임상적 이득이 작거나 없었습니다.

04

증상이 계속되면

산도검사 등으로 원인을 다시 살펴보고 증상에 맞는 진료를 연결합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약을 늘리기 전에 원인을 다시 살펴요

PPI에 반응하지 않았다는 사실만으로 원인을 결정하지 않습니다.

01

위산이 남아 있는 경우

PPI 두 배 용량에도 반응하지 않은 환자 분석에는 위산 관련 역류질환이 일부 남아 있었습니다.

02

과민성이 중심인 경우

역류과민성·기능성 가슴쓰림은 위산 억제 이외에 **통증** 신호를 조절하는 치료를 고려합니다.

03

증상을 구체적으로

명치가 불편한지, 가슴이 쓰린지, 식후 포만감이 있는지에 따라 진단과 치료 방향이 달라집니다.

왜 생기나요

조임근이 풀리고 배 속 압력이 오르는 일이 일상에서 쌓입니다

체중·배 속 압력

비만·복부비만은 역류 위험을 높입니다.
2025년 연구에서 체질량지수(BMI)가 10
높을 때 역류질환 위험은 약 68% 높았습니다.

식습관

과식·야식·식후 바로 눕기·기름진
음식은 위가 비워지는 것을 늦춥니다.

담배·술·카페인

식도와 위 사이 조임근을 직접 느슨하게 만듭니다.

먹는 약

일부 혈압약(칼슘차단제)·협심증약(질산염)·
천식약 — 먹는 약을 함께 점검합니다.

구조 이상

위 일부가 가슴 쪽으로 올라가는
식도열공탈장이 함께 있을 수 있습니다.

스트레스

증상을 더 **예민하게 느끼게** 하고
식습관도 나빠지게 합니다.

Tip · 바꿀 수 있는 원인부터 — 체중·식습관·담배·술이 상담의 우선순위입니다.

근거 · ACG 역류질환 지침 2022 · Mao, Frontiers in Physiology, 2025

재발하면 유지치료 방식을 맞춥니다

재발 정도에 따라 지속복용·필요시 복용을 선택합니다.

01

비미란성·경한 식도염

필요할 때 **PPI** 또는 P-CAB을 복용하는 유지 방식이 제시됐습니다. 증상의 재발 양상을 함께 봅니다.

02

심한 미란성 식도염

매일 지속하는 P-CAB 또는 **PPI** 유지치료가 제시됐습니다. 가벼운 질환의 필요시 복용과 구분합니다.

03

장기 복용 용량

증상을 조절하고 점막 치유를 유지하는 **가장 낮은 유효용량**으로 맞추도록 소개했습니다.

04

주기적으로 치료를 살펴요

재발이 반복되는지와 약의 효과를 함께 살피면서 유지치료를 조정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

어떻게 진단하나요

대표 증상이 뚜렷하면 먼저 진단하고 약으로 치료를 시작합니다



설명용 그림 · 의사가 내시경 화면으로 식도를 살펴봅니다. 목·위·밤 증상도 함께 확인합니다.

1. **증상 확인** 진료
   증상이 얼마나 잦은지, 체중 감소·삼킴 곤란·출혈 같은 위험 신호가 있는지 봅니다.
2. **위산억제제 시험 치료** 8주
   위험 신호가 없다면 위산억제제(**PPI**)를 식전 하루 한 번 8주 복용합니다.
3. **위 내시경** 필요할 때
   위험 신호가 있거나 약이 잘 안 듣거나 50세 이상에 새로 생긴 증상일 때. 식도염 정도를 A~D 네 단계(LA 분류)로 나눕니다.
4. **정밀 검사** 드물게
   24시간 식도 산도·임피던스 검사, 식도 운동(내압) 검사 — 약이 안 듣거나 수술을 생각할 때.

Tip · 모든 분이 내시경부터 하지는 않습니다 — 위험 신호가 있으면 먼저 합니다.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 리옹 합의 2.0 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

내시경이 정상이면 어떻게 구분할까요?

24시간 산도검사에서 위산 노출과 증상 사이의 관계를 봅니다.

01

비미란성 역류질환

내시경에 미란이 없어도 **위산 노출**이 비정상적으로 많으면 비미란성 역류질환으로 분류합니다.

02

역류과민성

위산 노출은 정상 범위지만, 역류가 일어난 시점과 증상이 시간상 연결되는 경우입니다.

03

기능성 가슴쓰림

위산 노출이 정상이고 역류와 증상 사이의 시간적 관련성도 없는 경우입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

PPI와 P-CAB은 복용 특성이 달라요

처방받은 약의 종류와 복용 시간을 함께 확인합니다.

구분	PPI	P-CAB
식사와의 관계	식사 30분–1시간 전 복용	식사와 무관하게 작용
작용 방식	산에서 활성화되는 전구약물	직접 작용하는 약물
안정된 억제 효과	새 펌프까지 억제하는 데 3–5일	첫 복용 1시간 이내 작용·첫날 최대 억제

오래 치료하거나 치료를 더할 때

역류질환이라는 근거를 더 분명히 확인하는 상황입니다.

객관적인 근거

장기 유지치료·약제 증량·수술 또는 **내시경** 시술을 고려할 때는 내시경이나 역류검사에서 근거를 확인합니다.

검사에서 보는 것

식도 점막의 손상 정도, 산에 노출된 시간, 역류 횟수, 증상과 역류의 관련성을 함께 평가합니다.



내시경 소견과 증상 양상을 진료실에서 함께 살펴봅니다.

약물 치료 — 위산을 줄이는 것이 중심입니다

처방받은 기간을 지키는 것이 가장 중요합니다 — 내시경으로 확인된 경우 건강보험이 적용됩니다

약 종류	대표 약과 먹는 법
위산억제제(PPI) 1차 치료	에소메프라졸 등 · 식전 30~60분 · 하루 한 번 8주 시험 치료
칼륨경쟁적 위산억제제	테고프라잔·보노프라잔 · 식사와 상관없이, 빠르게 위산을 줄임
H2 차단제·제산제	증상이 가벼울 때 보조로 · 바로 가라앉히려면 물약 제산제
위장운동 촉진제	위가 늦게 비워질 때 보조로 · 이것만 단독으로는 권하지 않음



설명용 그림 · 정해진 시간에 약을 먹으면 위산이 줄어 식도 점막이 회복됩니다.

Tip · 좋아져도 처방 기간은 지키세요 — 갑자기 끊으면 위산이 오히려 늘 수 있습니다.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약을 시험적으로 써볼 수 있습니다

전형적인 가슴쓰림·신물역류가 있을 때의 접근입니다.

01

1

증상 구분

명치 불편감인지 가슴쓰림인지, 신물역류가 함께 있는지 살핍니다.

02

2

시험치료

표준용량 **PPI**를 2주 사용하는 시험치료입니다.

03

3

반응 평가

호전되면 역류질환 치료를 이어가며 상태를 평가합니다.

04

4

지속 증상

반응하지 않거나 비전형적인 증상이 있으면 **산도검사** 등을 고려합니다.

처음 치료하는 기간은 중증도에 따라 달라요

2025 Seoul Consensus를 강의에서 소개한 내용입니다.

비미란성·경한 식도염

표준용량 PPI 또는 P-CAB

- 초기 치료기간은 4–8주로 제시됐습니다.
- 비미란성 역류질환과 경한 미란성 식도염에 해당합니다.
- 약의 반응과 증상 경과를 진료에서 살핍니다.

심한 미란성 식도염

표준용량 P-CAB 또는 PPI

- 초기 치료기간은 8주로 제시됐습니다.
- 심한 식도염과 가벼운 질환의 치료기간을 구분합니다.
- 치료 후에는 유지 방식도 중증도에 맞춰 정합니다.

음식 — 피할 것과 권하는 것

사람마다 다릅니다. 내 증상을 나빠지게 하는 음식부터 피하세요

내게 맞으면 줄이기

증상을 부르기 쉬운 음식·습관 — 일괄 금지는 아닙니다

- 기름진 음식·튀김, 맵고 향신료가 강한 음식
- 커피·홍차·콜라 같은 카페인 음료
- 초콜릿·박하사탕
- 술(특히 밤에 마시는 술)
- 오렌지·토마토 같은 신 과일, 탄산음료·야식

권장

역류를 줄이는 먹는 방법

- 천천히, 잘 씹어 먹기
- 한 번에 먹는 양은 줄이고 여러 번 나눠 먹기
- 식후 4시간은 눕지 않기 · 자정에 주무시면 저녁은 20시(8시) 전에
- 현미·채소·통곡물 같은 식이섬유
- 생선·닭가슴살 같은 저지방 단백질, 미지근한 물

Tip · 일괄 금지보다 — 먹고 나서 증상이 생긴 음식을 기록해 내 유발 음식을 찾아보세요.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

생활습관 — 약의 효과를 좌우합니다

약과 함께 반드시 실천하세요

1 적정 체중 유지 근거 가장 강함
5~10% 감량은 지침 수치가 아닌 관행적인 목표입니다. 개인 목표는 진료에서 정합니다.

2 금연·절주
담배·술은 조임근을 느슨하게 해 역류를 직접 일으킵니다.

3 상체를 높여 자기 15~20cm
침대 머리 쪽 다리를 높이거나 쐐기형 베개 — 베개만 높이면 효과가 덜합니다.

4 배 조이지 않기
꽉 끼는 벨트·옷을 피하고 식사 직후 허리 굽히기를 줄입니다.

5 식후 가벼운 활동
식후 바로 눕거나 격렬한 **운동**은 피하고 가볍게 걷습니다.

6 왼쪽으로 누워 자기
오른쪽보다 밤사이 역류가 줄었다는 보고가 있습니다.



설명용 그림 · 저녁을 일찍 가볍게 먹고, 상체를 높여 왼쪽으로 눕고, 체중을 관리합니다.

Tip · 생활습관 가운데 근거가 가장 강한 것은 체중 감량입니다.

근거 · ACG 역류질환 지침 2022 · 서울 합의 2020 — 5~10%는 지침 수치 아님

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

다음 진료에서 이 순서로 정리해요

증상·검사·약 반응을 함께 보며 관리 계획을 맞춥니다.

01

1

어디가 불편한가요

명치와 가슴, 목의 증상을 구분해 설명합니다.

02

2

어떤 약을 쓰나요

약 이름과 복용 시간을 함께 확인합니다.

03

3

얼마나 달라졌나요

호전·지속·재발 양상을 살펴봅니다.

04

4

어떻게 이어갈까요

검사 필요성과 유지치료 방식을 정합니다.

금연 · 절주 · 운동 · 호흡 훈련

약·식사와 함께 챙기면 좋은 습관입니다

금연 — 전자담배도

니코틴은 조임근을 느슨하게 하고 침을 줄입니다. 정상 체중·약을 안 쓰는 분에서 끊으면 심한 증상이 뚜렷이 줄었습니다.

절주 — 양과 때

마실수록 위험이 오릅니다. 줄였을 때의 연구는 부족해, 식후 많이·**잠들기 전 마시는 술**부터 줄입니다.

운동 — 주 150분 중강도

규칙적인 중강도 유산소 **운동**은 역류 위험을 낮춥니다(33편·242,850명 분석).

식후 바로 강한 운동은 피하기

식후 2시간 안의 달리기·무게 **운동**·윗몸일으키기는 배 속 압력을 갑자기 올려 역류를 부릅니다.

복식호흡 — 바깥 조임쇠

배로 숨 쉬는 훈련으로 식도 아래 조임이 강해지고 식후 역류·증상·삶의 질이 좋아졌습니다.

복식호흡 — 하루 20분 · 4주

매일 20분씩 4주 넘게 했을 때의 결과입니다. 미국소화기협회(AGA) 2022 권고에 들어 있습니다.

Tip · 운동은 식사 2시간 뒤, 호흡 훈련은 식후에 천천히 해 보세요.

근거 · HUNT(PMID 24322837) · Pan 2019 · 운동 메타분석 2024 · 미국소화기협회(AGA) 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이럴 땐 바로 진료를 받으세요

혼자 관리하지 마세요 — 출혈이나 심한 가슴 통증은 바로 응급실로 갑니다



삼키기 어려움

음식이 걸리거나 잘 안 넘어갑니다. **식도가 좁아졌거나 종양인지** 확인해야 합니다.



뜻하지 않은 체중 감소

3~6개월 사이 체중이 5% 넘게 빠졌을 때.



검은 변·피를 토함

검은 변, 피를 토함, 커피 찌꺼기 같은 구토물 — 출혈일 수 있어 바로 **응급실**로.



처음 겪는 가슴 통증

심장 원인부터 확인합니다. 쥐어짜듯 아프고 식은땀이나 숨참이 있으면 119.



약이 잘 안 들을 때

위산억제제를 8주 충분히 먹어도 증상이 남거나 다시 생깁니다.



50세 이상 새 증상

늦게 시작된 역류 증상은 꼭 **내시경**으로 확인합니다.

Tip · 위험 신호가 있으면 약이 듣든 안 듣든 내시경 검사를 받습니다.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘부터 실천할 일곱 가지

작은 습관 변화가 약물치료의 효과를 결정합니다

01
식후 4시간은 눕지 않기

02
잠들기 4시간 전까지 식사 마치기

03
야식·과식 끊기

04
커피·술·담배 줄이거나 끊기

05
잠자리 머리 쪽 15~20cm 높이기

06
꽉 끼는 옷·벨트 피하기

07
처방약은 마음대로 끊지 않고 먹기

Tip · 8주 꾸준히 지키면 증상이 좋아지는 경우가 많습니다 — 매일 체크해 습관으로 만드세요.

근거 · 미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 집에서 실천할 내용은 한 장 안내문으로 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

역류성 식도염 진단을 받았거나 증상이 있는 분을 위한 생활관리 설명자료입니다. 약과 검사는 담당 의사와 상의해 정합니다.

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

참고한 자료

미국소화기학회(ACG) 역류질환 진료지침 2022 · 대한소화기학회 역류성 식도염 진료지침 · 몬트리올 정의 2006 · 리옹 합의 2.0 2023

함께 보기 — 역류성 식도염 생활관리 A4 edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/gerd-lifestyle-2026/